

Datos Personales							
Nombre:	JERONIMO CALDERÓN PRENTT	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2019-02-17	Edad	7 Años, 1 Meses, Y 6 Días
Identificación:	TI - 1066301336	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Yesiprentt@hotmail.Com - 1066301336			Dirección:	Mz 2 Casa 6 Altos Del Valle		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		YESINA PRENTT - Parentesco (madre) - Teléfono (312 8374495)					

Apertura psicología del 2025-07-25 00:40:34: 7 años, 1 meses, y 6 días

DATOS GENERALES

Remisión

Remitido por Especialidad de Neuropsicología Clínica.

DX principal

F840 - AUTISMO EN LA NINEZ

DX Relacionado 1

F808 - OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

DX Relacionado 2

NREF - NO REFIERE

Código de consulta

890408 - INTERCONSULTA POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Refiere la madre y el padre "Tiene conductas de pegar a otros y se frustra con facilidad".

Enfermedad Actual

El paciente presenta un cuadro evolutivo desde la primera infancia, caracterizado por comportamientos de agresión hacia otras personas sin un desencadenante claro, inquietud motora y escasa percepción del riesgo. Aunque manifiesta sus necesidades y muestra mayor apertura social, aún presenta limitaciones para iniciar y mantener conversaciones funcionales, aunque logra responder a preguntas sencillas. Exhibe conductas de apropiación de objetos sin mediar consentimiento, mantiene selectividad alimentaria significativa, con rechazo marcado a frutas y verduras que deben ser ofrecidas de forma alternativa. A nivel académico evidencia un desempeño favorable, sin embargo, persiste la dificultad para reconocerse en primera persona, a pesar de emitir respuestas adecuadas en algunos contextos. En ocasiones se observan estereotipias motoras de frecuencia media. Cuenta con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1 y ha presentado progresos relevantes con el paso del tiempo. Fue remitido para evaluación y abordaje especializado debido a la persistencia de retraso en el desarrollo del lenguaje, limitaciones en competencias comunicativas, así como la presencia de conductas disruptivas y oposicionistas, manifestadas en golpes fuertes a otros usando puños cerrados, embestidas con la cabeza y patadas fuertes con ambas piernas. Se evidencia reactividad negativa ante estímulos auditivos de volumen alto o intermedio. Presenta baja tolerancia a la frustración, períodos reducidos de postura sedente cuando la actividad no resulta de su interés y mantiene un patrón de inquietud motora. Utiliza de forma funcional objetos que son de su preferencia y, en caso de no lograr obtener algo por iniciativa propia, recurre a la guía física para conseguirlo. Es parcialmente autónomo en algunas actividades básicas de la vida diaria.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico No Refiere	Tóxicos No Refiere
Traumáticos Ninguno	Medicación No Refiere
Paraclínicos No Refiere	Hospitalizaciones No Refiere
Patología No Refiere	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo 26 Años	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo Si	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo No	Estado De La Madre Durante El Embarazo Emociones Alteradas (cuadros Depresivos) Regulados.

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Natural	Causa De La Cesárea No Aplica
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3000
Talla Al Nacer 51	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido Días Después Del Nacimiento, Motivo (ictericia Fisiológica Neonatal).	Desarrollo Psicomotor Adecuado
---	--

ANTECEDENTES

Desarrollo Psicomotor

Control Cefálico 2M	Rolado 3M
Sedente Solo 4M	Gateo 6M
Bípodo Sin Ayuda 8M	Marcha 12M
Lenguaje Verbal 18M	Lenguaje Verbal Fluido ALTERADO

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos Diabetes, Hipertensión, Cáncer	Otros No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Actualmente el menor cursa el nivel de preescolar en la institución educativa Howard Gardner School, donde ha contado con acompañamiento pedagógico y seguimiento permanente debido a su condición diagnóstica. Según refiere la madre, participa de manera colaborativa en actividades relacionadas con el aseo y la organización del aula. No obstante, se observa limitación en la interacción social con pares, persistiendo conductas agresivas dirigidas hacia compañeros, manifestadas principalmente a través de golpes. A nivel académico, muestra mayor interés y disposición hacia áreas como lectoescritura, matemáticas, emprendimiento e inglés, siempre bajo orientación y supervisión docente.
Historia laboral No aplica.
Historia familiar Actualmente el paciente convive con su padre, el señor Álvaro Javier Calderón Camargo de 35 años, y su madre, la señora Yesina Yulieth Prent Orozco de 32 años. Los cuidadores manifiestan haber iniciado procesos de atención temprana enfocados en la valoración integral y la obtención de un diagnóstico preciso, mostrando alto nivel de compromiso con la rehabilitación y el plan terapéutico, manteniéndose atentos a controles médicos, recomendaciones profesionales y actividades asignadas. Se destaca una dinámica familiar funcional y de apoyo, sin embargo, se observa que el menor reproduce conductas agresivas similares en el contexto intrafamiliar, dirigidas hacia ambos progenitores.
Historia social No aplica.
Historia emocional/afectiva Desde el ámbito afectivo, se observa que el paciente presenta limitaciones significativas en la interacción y vinculación con pares, evidenciándose dificultad para establecer relaciones interpersonales funcionales dentro del contexto escolar. Aunque muestra disposición para colaborar en actividades colectivas relacionadas con el orden y la limpieza del aula, persisten conductas disruptivas y agresivas hacia compañeros de clase y miembros del grupo familiar, expresadas principalmente mediante golpes e impulsividad. En el entorno familiar, se mantiene una relación de cuidado, contención y supervisión por parte de los padres, quienes manifiestan interés en fortalecer las habilidades comunicativas y regular la expresión conductual del menor, no obstante, las manifestaciones agresivas continúan presentes en el vínculo con los cuidadores. A nivel emocional, se identifican respuestas de frustración ante estímulos no deseados o situaciones de no cumplimiento de sus intereses, así como baja tolerancia ante estímulos sensoriales adversos.

Historia deportiva

Actualmente no practica ningún deporte.

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Evaluación psicológica inicial

- Evaluación y Entrevista Psicológica a la madre y el padre.
- FAI (Entrevista de Evaluación Funcional) con la madre.
- Escala de Conducta Adaptativa – Residencias – y Comunidades Segunda edición con la madre.
- F.A.S.T (Herramienta de Evaluación Funcional) con los padres.
- MAS (Escala para Evaluación de Motivación) con los padres.
- Observación directa al niño.
- Tiempo de juego para evaluar y establecer las conductas a modificar y fortalecer.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

- Control y seguimiento por Psiquiatría Infantil, quien afirma Dx F840 Autismo en la niñez. Realiza remisión para rehabilitación con Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Terapia Física y Psicología y control el 6 meses. En el último control el día 22 de febrero de 2024, solicita "informe del colegio acerca del comportamiento, concentración, socialización, seguimiento de instrucciones y emociones". Dr. Juan David Avila Cadavid.

Intervención neurológica

Control y seguimiento por Neuropediatría, quien afirma Dx F840 Autismo en la niñez. Realiza remisión para rehabilitación con Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Terapia Física y Psicología Terapia ABA, evaluación integracion sensorial, aplicación de pruebas neuropsicológicas para valorar funciones cognitivas y ejecutivas y control en 3 meses. Dra. Maria J. Torres Nieto.

- Evaluación sensorial realizada el dia 4 de mayo de 2025, en las conclusiones refiere el especialista "El niño presenta una marcada búsqueda de estimulación de movimiento y dificultades para permanecer en calma, lo que mantiene un nivel de alerta elevado. Se identifica un déficit en la **modulación sensorial**, especialmente de estímulos táctiles y propioceptivos, generando reacciones exageradas ante ciertas sensaciones (hiperrespuesta) y rechazo a texturas novedosas. Esta disfunción lleva a que el menor busque de forma desorganizada estímulos de presión o movimiento intenso para autorregularse, pero, en lugar de calmarse, incrementa su estado de alerta y agitación, impactando otras áreas como el procesamiento auditivo. Por ello, se recomienda como fase inicial de intervención fortalecer la integración y modulación propioceptiva mediante actividades vestibulares lineales, y posteriormente, trabajar la exposición gradual a estímulos táctiles, favoreciendo la regulación y mejor interacción con el entorno". Dr. German Burguillos.

Intervención neuropsicológica

Aplicación de pruebas Neuropsicológicas el día 15 de mayo de 2025, en las conclusiones refiere el especialista "De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas aplicadas y la observación clínica, se identifica el siguiente perfil neuropsicológico: **1)Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1** (anteriormente conocido como síndrome de Asperger), con una marcada afectación en el área del comportamiento, acompañado de **2) Discapacidad intelectual leve + Retraso en el lenguaje expresivo, receptivo y comprensivo**, presentando un mayor desarrollo en el componente manipulativo que en el verbal. A pesar de que ambos procesos se encuentran por debajo del promedio esperado para su edad, se ha observado que el canal manipulativo representa una vía más eficaz de aprendizaje para el menor". Dr. Jainer E. Guzman Vega.

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

Paciente ingresa a consulta en compañía de sus padres, se observa un niño con apariencia acorde a su edad cronológica, con presentación e higiene adecuadas bajo supervisión de sus cuidadores, evidenciándose inquietud motora constante y dificultad para permanecer en postura sedente por periodos prolongados, con tendencia a desplazarse continuamente en busca de estimulación propioceptiva. Muestra cooperación parcial, respondiendo mejor bajo acompañamiento cercano, pero presenta episodios de irritabilidad y conductas disruptivas cuando se enfrenta a actividades que no resultan de su interés o ante estímulos sensoriales no regulados. Se mantiene alerta, con adecuada respuesta a estímulos de interés, aunque persisten limitaciones para ubicarse en tiempo y espacio de forma completa, así como para reconocerse plenamente en primera persona. A nivel lingüístico, presenta lenguaje expresivo limitado, con dificultad para organizar discurso espontáneo y sostener conversaciones funcionales, mostrando respuesta a preguntas simples y ecolalia ocasional. Su estado afectivo es congruente con el contexto, destacándose baja tolerancia a la frustración, hipersensibilidad frente a estímulos auditivos y táctiles, reactividad agresiva ante situaciones que generan incomodidad o estrés y tendencia a la hipervigilancia. No se evidencian alteraciones perceptuales de tipo psicótico, aunque persiste la hiperrespuesta sensorial que ocasiona reacciones de sobresalto, evitación o bloqueo. El pensamiento se manifiesta de forma concreta, con dificultades en la coherencia y secuencia lógica extendida, intereses restringidos y patrones repetitivos que limitan la flexibilidad cognitiva. A nivel cognitivo, muestra rendimiento académico favorable en áreas de su interés como lectoescritura, matemáticas e inglés, siempre que exista estructura y supervisión constante, presentando dificultades en la modulación sensorial que interfieren con la atención sostenida y la ejecución de tareas. El insight es limitado, propio de su etapa evolutiva y condición diagnóstica, y el juicio parcialmente conservado, con dificultad para anticipar consecuencias de conductas impulsivas y riesgos potenciales. Se evidencia conducta motora caracterizada por inquietud elevada, golpes hacia pares o cuidadores y búsqueda de contacto físico de forma desorganizada. El cuadro observado es consistente con su diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y disfunción en integración sensorial, lo cual impacta su regulación conductual, emocional y comunicativa.

Ciclos del Sueño

La mayoría de los días mantiene los ciclos del sueño conservados, sin embargo, hay ocasiones repetidas donde se alteran los ciclos del sueños lo cual le conlleva a irritabilidad emocional y agotamiento durante el día.

Apetito

No toma jugos ni sopa y no come frutas ni verduras.

Actividades de Autocuidado

Dependiente, con supervisión constante.

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F840 - AUTISMO EN LA NINEZ

Impresión Diagnóstica Relacionada 1

F808 - OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE
Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE
Establecido por primera vez
No
Objeto de atención clínica
NO REFIERE

PLAN DE INTERVENCIÓN
Plan de Intervención
Objetivo General
Fortalecer la autorregulación emocional y conductual del paciente, reduciendo conductas disruptivas y agresivas, y potenciando habilidades comunicativas y sociales significativas mediante estrategias terapéuticas basadas en el Análisis de Conducta Aplicado (ABA) y la orientación clínica individual y familiar.
Objetivos Específicos
• Identificar y analizar los antecedentes y consecuencias de las conductas disruptivas para diseñar planes de manejo conductual desde ABA. • Implementar técnicas ABA para aumentar conductas adaptativas y disminuir respuestas inadecuadas, empleando reforzadores motivadores y estructuración del entorno. • Fomentar el uso funcional del lenguaje y estrategias de comunicación alternativa para reducir la dependencia de la ecolalia y minimizar la frustración. • Diseñar rutinas estructuradas y actividades motivantes que faciliten la permanencia en tareas y mejoren la tolerancia a la espera. • Brindar psicoeducación continua a la familia y docentes para que se conviertan en co-terapeutas activos, reforzando en casa las técnicas ABA y la regulación conductual.
Sugerencias e Interconsultas
• Iniciar de manera Prioritaria Tratamiento con Terapia Ocupacional (Con especialidad en integración sensorial). • Control con Psiquiatría infantil.
Observaciones y Recomendaciones
• Implementar en casa los principios básicos del ABA: reforzar de inmediato las conductas deseadas, ignorar conductas inadecuadas cuando sea seguro hacerlo y modelar respuestas alternativas. • Mantener una rutina diaria estructurada con tiempos de actividad y pausas sensoriales programadas para favorecer la regulación emocional. • Usar ayudas visuales (tableros, pictogramas) para anticipar cambios y dar instrucciones claras. • Fomentar momentos de juego funcional y estructurado que estimulen la interacción positiva y el autocontrol. • Participar activamente en seguimiento de la intervención, asistiendo puntualmente a las sesiones y manteniendo comunicación constante con el equipo terapéutico. • Implementar PIAR en la institución educativa.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU

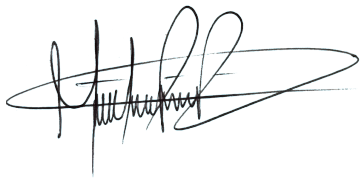
Datos Personales							
Nombre:	JERONIMO CALDERÓN PRENTT	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2019-02-17	Edad	7 Años, 1 Meses, Y 6 Días
Identificación:	TI - 1066301336	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Yesiprentt@hotmail.Com - 1066301336			Dirección:	Mz 2 Casa 6 Altos Del Valle		
Departamento:	CESAR	Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		YESINA PRENTT - Parentesco (madre) - Teléfono (312 8374495)					

Impresión Diagnóstica:
F840 - AUTISMO EN LA NINEZ

Impresión Diagnóstica Relacionada 1
F808 - OTROS TRASTORNOS DEL DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

Impresión Diagnóstica Relacionada 2
NREF - NO REFIERE

ÓRDENES MÉDICAS		
No.	PROCEDIMIENTO	CANTIDAD
1	890384 - CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN PSIQUIATRIA OBSERVACIÓN: Medicación Que Permita Regular El Sistema Nervioso, Alteración Sensorial Y Emocional.	1



DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU



PRASCA
CENTER